ACTIVACIÓN DE UNIDADES VÍA MENSAJERÍA (ECHO V2)

Área de operaciones

Gerencia Urgencias y Emergencias

Saturnino Romero Soto (TES del Centro Coordinador de Urgencias).

TABLA DE MODIFICACIONES

FECHA	MODIFICACIÓN	AUTOR

INDICE

1. Introducción. Sistema actual.

2. Introducción de mensajería de texto: contenidos.

3. Objetivos de este procedimiento

4. Procedimientos de activación Operadores CCU 061.

   a. Activación telefónica de unidades UME y SUAP/PAC.
   b. Activación radiotelefónica (TETRA) de unidades UME y SUAP/PAC.
   c. Activación telefónica de Ambulancias No Asistenciales (ANA).
   d. Activación de asunto pendiente para unidad.

5. Recepción de activación en unidades.

6. Documentos base.

1. Introducción. Situación actual.

El Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región de Murcia, se encuentra integrado, funcional y físicamente, en la Sala de Operaciones del 112, dependiente esta de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias (DGSCyE), desde donde se realiza la gestión de las urgencias y emergencias sanitarias extrahospitalarias que se reciben a través del teléfono único de emergencias 112 de la Región de Murcia o por cualquier otro medio.

En la actualidad, se gestionan diariamente, respecto al Servicio Murciano de Salud: 17 Unidades Móviles de Emergencia, 27 Servicios de Urgencia de Atención Primaria, 12 Puntos de Atención Continuada, 9 Puntos de Especial Aislamiento, 35 Ambulancias No Asistenciales. Igualmente se gestionan todas las unidades no asistenciales y asistenciales que prestan servicio con convenio específico con el Servicio Murciano de Salud, diariamente 5 Soportes Vital Básico.

Al dar cobertura a 1.4 millones de habitantes en la Región de Murcia, que debemos sumar el incremento estacional, durante el año 2015, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia atendió durante el año 2015 un total de 1.333.769 llamadas, lo que hace una media de 3.681 llamadas al día. El número de llamadas atendidas relativas a temas sanitarios han alcanzado la cantidad de 488.028, lo que da una media 1337 llamadas por asuntos sanitarios al día.

Por ejemplo, durante el año 2014, se realizaron un total de 197.175 movilizaciones de recursos, 66.163 consultas telefónicas y 10.883 solicitudes de información sanitaria.

Actualmente, todas las movilizaciones de recursos, se realizan transcribiendo la información por voz, al dictado del tomador de la información. Dada la presión asistencial, la complejidad de facilitar la información sanitaria, transcribiendo fielmente todos los detalles pero que no demore el tiempo de activación; se propone, al amparo de las nuevas posibilidades que permite la tecnología de la plataforma ECHO (Emergencias: Control Holístico Operativo), la introducción de un sistema de mensajería que facilite a la unidad gran parte de la información de un modo inmediato y

en texto, que se reforzará con los datos durante la confirmación de activación.

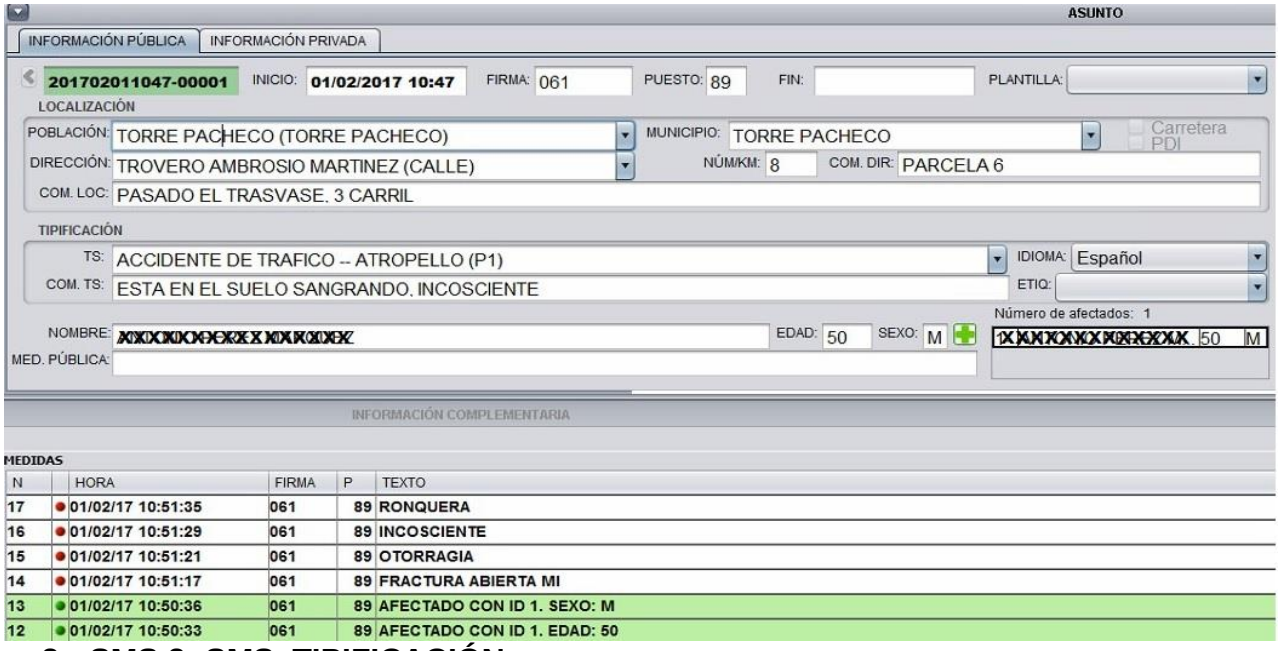
Este hecho, la suma de datos y activación por voz, se considera fundamental, dada la experiencia observada en otros Centros Coordinadores; donde se ha observado, como un punto “critico”, el protocolo combinado.

2. Introducción de mensajería de texto: contenidos.

Cuando un recurso sanitario sea asignado (estado A) por el Operador CCU 061, se enviará automáticamente dos SMS con la información del mismo. Estos SMS, contarán con el siguiente formato:

1. **SMS 1: SMS_DIRECCIÓN**:

[ORG][HORA]h[IDASUNTO][POB]([MUN]),[DIR],[NUM],[COM_DIR], [COM_LOC]



2. **SMS 2: SMS_TIPIFICACIÓN:**

[ORG][HORA]h[IDASUNTO][PACIENTE][TIPIFICACION]{[MEDIDAS_PRIVADAS_SANITARIAS],[MEDIDAS_PRIVADAS_SANITARIAS],..}

Caso práctico:

Los mensajes generados serían los siguientes:

SMS DIR: 061 10:47h 00001 TORRE PACHECO (TORRE PACHECO), TROVERO AMBROSIO MARTINEZ (CALLE),8,PARCELA 6,PASADO EL TRASVASE, 3 CARRIL
SMS TIP: 061 10:47h 00001 V50A ACCIDENTE DE TRAFICO -- ATROPELLO (P1) FRACTURA ABIERTA MI, OTORRAGIA, INCOSCIENTE, RONQUERA

Descripción de las etiquetas:

- **[ORG]:** Organismo que genera los SMS, en este caso será siempre 061.
- **[HORA]:** Hora de la creación del incidente en el siguiente formato hh:mm.
- **[IDASUNTO]:** Últimos 5 caracteres del asunto en ECHO.
- **[POB]:** Población del incidente.
- **[MUN]:** Municipio del incidente.
- **[DIR]:** Dirección del incidente.
- **[NUM]:** Num/Km del incidente.
- **[COM_DIR]:** Comentario de dirección del incidente.
- **[COM_LOC]:** Comentario de localización del incidente.
- **[PACIENTE]:** Paciente del incidente con el siguiente formato hombre o mujer (V o H), edad y “A”.
- **[TIPIFICACION]:** Tipificación del incidente.
- **[MEDIDAS_PRIVADAS_SANITARIAS]:** El texto de las medidas privadas sanitarias (medida privadas con firma ENF, 061 o MEDICO) separado por comas.

Estos mensajes tendrán un máximo de 160 caracteres, en el caso de que se supere ese tamaño se cortara este máximo. Después de asignar el recurso sanitario, el Operador CCU, **siempre** confirmará vía voz la misión al recurso.

3. Objetivos de este procedimiento.

La implantación de un procedimiento de activación eficiente y eficaz, que posibilite una transcripción de la información necesaria a la unidad/es asignadas, usando métodos

de comunicación, que permitan transmitir el mensaje de modo claro, corto y conciso, al tiempo que disminuya el tiempo necesario para transmitir la información necesaria, pero elevar la calidad de la información, evitando transcripciones defectuosas o demorar el tiempo de salida.

Esto permitirá la automatización de procedimientos más rutinarios, el dictado de datos, por la lectura combinada de datos con los datos esenciales facilitados por la activación verbal. Ello debe repercutir en optimizar la gestión de las unidades, geolocalización, seguimiento, apoyo logístico, activaciones de protocolos especiales, comunicaciones e introducción de datos generados durante la asistencia de modo protocolizado, que aseguren la trazabilidad de la actuación sanitaria de cada unidad.

4. Procedimientos de activación: Operadores CCU 061.

Tras la definición del recurso por Médico/Enfermero CCU, el Operador CCU realizará la activación del recurso de zona de influencia, comprobando previamente la concordancia de datos de localización, según el siguiente modo secuenciado:

1. **Asignar la unidad.** En este momento, el sistema automáticamente envía dos mensajes con la información señalada (Punto 2).
2. **Realiza la llamada de activación telefónica**, identificando:
   - Receptor (identificativo de unidad) y emisor (CCU).
   - Informando de activación.
   - Población/Pedanía/Barrio.
   - Calle (sólo nombre)/ tipo de vía y punto kilométrico, aclarando suceso en vía pública, en su caso.
   - Patología principal (TS).
   - Número de afectados, en sucesos múltiples.
   - Unidades movilizadas o en proceso de movilización, en su caso.
   - Tras lo que confirmará la recepción afirmativa de los mensajes.

Si la unidad, informa que no ha recibido los datos, procederá al dictado de la información señalada, añadiendo los datos necesarios, según nivel asistencial (ver punto 4). Debido a los diferentes métodos de transmisión y niveles asistenciales de las unidades coordinadas por CCU, se enumeran más adelante detalladamente.

Información sobre localización:

Dada la limitación de contenido de un mensaje de texto, si la información sobre la localización es más extensa de lo habitual, el Operador CCU, facilitará verbalmente los datos sobre la ubicación del asunto, confirmando la recepción por la unidad.

Si la unidad requiere apoyo adicional para la localización del asunto, además de la información facilitada en el mensaje 1 y la activación verbal, el Operador CCU usará todas las herramientas del sistema para ello: geolocalización en base de datos de *Emersig* y cartografía en web; si a pesar de ello no está definida, o en el caso en que los datos aportados a Atención de Llamadas, son discordantes, procederá realizar llamada a alertante, recabando nuevos datos, que facilitará a unidad. Estas circunstancias, se reflejarán en la carta de llamada.

En caso de puntos de referencia poco definidos, el Operador CCU, podrá optar por realizar conferencia/mediación entre unidad, llamante y CCU, para confirmar la localización exacta del suceso. Esto, se reflejará en la carta de llamada.

En los casos que sea necesario, recabará el apoyo de los organismos necesarios (fuerzas de seguridad) a través de CECOP o directamente, si es más operativo, la interlocución directa con el organismos, **tras lo que informará de dichas circunstancias a Médico CCU.**

Si durante la gestión del asunto, el alertante aporta o corrige datos sobre la localización del asunto, el Operador CCU recibirá notificación de Atención de Llamadas de este hecho, que trasladará a la unidad asignada, confirmando la recepción y localización.

Información sobre motivo de llamada/ tipificación:

La información principal del sobre el motivo de llamada (TS), será facilitada el Operador CCU durante la activación a la unidad verbalmente, que irá acompañada por la información que el Medico/Enfermero CCU considere necesario destacar, recibida a través del sistema de mensajería en el mensaje 2.

Dada la limitación de contenido de un mensaje de texto, si la información sanitaria, contenida en medidas privadas sanitarias, es más extensa de lo ordinario, el Operador CCU, facilitará verbalmente los datos sanitarios, confirmando la recepción por la unidad.

Si durante la gestión del asunto, son aportados nuevos datos sanitarios, el Médico/Enfermero CCU, los reflejará en medidas privadas sanitarias y notificará este hecho al Operador CCU, que transmitirá estos datos a la unidad asignada.

Debido a la urgencia de un asunto, mientras se recaban nuevos datos, el Médico/Enfermero CCU puede decidir la movilización de la unidad con los datos de patología principal (TS), mientras realiza la gestión del asunto, recabando datos adicionales. Tras la decisión de movilización, el Operador CCU, activará la unidad, señalando en medidas privadas la circunstancia (**Recabando información**) que recibirá la unidad en su 2º mensaje de texto.

Si durante la gestión del asunto, el alertante aporta o corrige datos sobre la patología del alertante, el Médico/Enfermero CCU recibirá notificación de Atención de Llamadas de este hecho. El Operador CCU, recibirá la alerta igualmente, para trasladar la información a la unidad asignada, previo filtrado de Médico/Enfermero CCU, confirmando la recepción.

Notificaciones sobre nuevos datos entre CCU:

La comunicación de nuevos datos, debe de realizarse de modo que deje constancia en la carta de llamada, en las comunicaciones referentes al asunto en gestión (intercom+carta), entre organismos, al realizar comunicaciones sobre el grupo sanitario, Atención de Llamadas, como entre el propio grupo sanitario, Médico, Enfermero y Operador CCU.

Activaciones de unidades según medio de transmisión y nivel asistencial:

Debido a los diferentes niveles asistenciales de las unidades movilizadas desde CCU, así como la posibilidad de la activación telefónica o radiotelefónica, se definen

procesos por nivel asistencial de unidad y medio de transmisión de activación del siguiente modo:

a. <u>Activación telefónica de unidades UME y SUAP/PAC.</u>

1. **Asignar la unidad.** En este momento, el sistema automáticamente envía dos mensajes con la información señalada (Punto 2).

2. **Realiza la llamada de activación telefónica**, identificando:
   - Receptor (identificativo de unidad) y emisor (CCU).
   - Informando de activación.
   - Población/Pedanía/Barrio.
   - Calle (sólo nombre)/ tipo de vía y punto kilométrico, aclarando suceso en vía pública, en su caso.
   - Patología principal (TS).
   - Número de afectados, en sucesos múltiples.
   - Unidades movilizadas o en proceso de movilización, en su caso.
   - Tras lo que confirmará la recepción afirmativa de los mensajes.

b. <u>Activación radiotelefónica (TETRA) de unidades UME y SUAP/PAC.</u>

Se realizará este sistema, cuando CCU tenga contacto por línea radiotelefónica (TETRA) con la unidad o cuando la comunicación telefónica no sea posible y la localice a través de radiotelefonía, informándole de la activación, tras lo que, el Operador CCU le informa de activación y de realización de llamada telefónica:

1. **Asignar la unidad.** En este momento, el sistema automáticamente envía dos mensajes con la información señalada (Punto 2).

2. **Realiza la llamada de activación telefónica**, identificando:
   - Receptor (identificativo de unidad) y emisor (CCU).
   - Informando de activación.
   - Población/Pedanía/Barrio.
   - Calle (sólo nombre)/ tipo de vía y punto kilométrico, aclarando suceso

en vía pública, en su caso.
- Patología principal (TS).
- Número de afectados, en sucesos múltiples.
- Unidades movilizadas o en proceso de movilización, en su caso.
- Tras lo que confirmará la recepción afirmativa de los mensajes.

3. En caso de no contar con línea telefónica, realizará la llamada de activación radiotelefónica (TETRA), informándole de los mismos datos y confirmando la recepción de mensajes.

c. <u>Activación telefónica de Ambulancias No Asistenciales (ANA).</u>

1. **Asignar la unidad.** En este momento, el sistema automáticamente envía dos mensajes con la información señalada (Punto 2).

2. **Realiza la llamada de activación telefónica**, identificando:
   - Receptor (identificativo de unidad) y emisor (CCU).
   - Informando de activación.
   - Población/Pedanía/Barrio.
   - Calle (sólo nombre)/ tipo de vía y punto kilométrico, aclarando suceso en vía pública, en su caso.
   - Patología principal (TS) o motivo de traslado: petición de traslado no asistencial por unidad UME/SUE, derivación médica, etc.
   - Número de afectados, en sucesos múltiples.
   - Unidades movilizadas o en proceso de movilización, en su caso.
   - En altas hospitalarias se facilitará el nombre.
   - Tras lo que confirmará la recepción afirmativa de los mensajes.

d. Activación de asunto pendiente para unidad.

En los asuntos que el Médico/Enfermero CCU, considere que puede esperar a que la unidad de zona, finalice el asunto asignado, esta petición, quedará pendiente para la unidad.

Cuando la unidad finalice el asunto, comunicando al CCU su finalización, el Operador CCU, tras la recogida de datos; le informará de dicha circunstancia,

asignará en el asunto pendiente de realización, según la prioridad señalada por el Médico/Enfermero CCU y actuará según los procedimientos descritos anteriormente, de acuerdo al medio de transmisión y el nivel asistencial de la unidad asignada.

En los casos, en los que la urgencia del asunto en curso, sea necesario, señalada por el Médico/Enfermero CCU, se informará de dicha circunstancia a la unidad, primando la información de activación, quedando la recogida de datos pendiente en la finalización posterior.

Situaciones especiales:

En las situaciones de **movilización de unidad fuera de su área habitual** de influencia, la primera información a recibir por la unidad, será esta; de este modo se pretende agilizar la respuesta.

En estas situaciones, a requerimiento del Medico/Enfermero CCU, el Operador CCU informará de los estados (E,C,B, L y D) y ubicación (en su caso) de las unidades más cercanas a la zona de influencia.

En los **sucesos con múltiples pacientes/ multiplex unidades**, dada la limitación de información transmitida por mensajería de texto. El operador CCU, aportará la siguiente información adicional a la unidad verbalmente, si cuenta con ella, durante la activación:

- Número aproximado de afectados.
- Número de unidades movilizadas y nivel asistencial.

Si estos datos, son posteriores a la activación, el Operador CCU, transmitirá los datos, durante la misión. En caso necesario, por la isócrona diferida de las unidades adicionales, informará a la unidad que por isócrona, sea la primera en llegar, de los puntos/tiempo de salida de estas unidades.

En cualquier caso, **cualquier incidencia durante la activación del recurso, será comunicada a Médico CCU**, informándole de la situación y la actividad realizada para el éxito de la activación del recurso, que decidirá la actuación a seguir, si considera necesario la realización de actividades adicionales.

5. Recepción de activación desde las unidades.

Las comunicaciones de Operador CCU con unidades realizarán a través del teléfono móvil facilitado a la unidad, que portará el técnico/conductor o el Médico, según la operativa establecida en la base. Así como de modo secundario, se usará el sistema de radiotelefonía TETRA.

Activación:

La unidad recibirá una llamada de teléfono, informándole de su activación, informándole de los datos verbalmente:

- Receptor (identificativo de unidad) y emisor (CCU).
- Informando de activación.
- Población/Pedanía/Barrio.
- Calle (sólo nombre)/ tipo de vía y punto kilométrico, aclarando suceso en vía pública, en su caso.
- Patología principal (TS).
- Número de afectados, en sucesos múltiples.
- Unidades movilizadas o en proceso de movilización, en su caso.
- Confirmando la recepción de mensajes.

En caso de problemas de recepción de mensajes, se procederá al dictado verbal de los datos de activación.

En caso de cualquier incidencia en la localización, solicitará apoyo al Operador CCU, que actuará según procedimiento descrito en Punto 4 (**Información sobre Localización**).

En las ocasiones que el Médico Responsable de la Unidad, considere necesario, más información sobre la patología del paciente, solicitará información adicional al Operador CCU que aportará la información disponible como señala el Punto 4 (**Información sobre Tipificación**).

En ocasiones, debido a la urgencia de un asunto, mientras se recaban nuevos datos, el Médico/Enfermero CCU puede decidir la movilización de la unidad con los datos de patología principal (TS), mientras realiza la gestión del asunto, recabando

datos adicionales. Tras la decisión de movilización, el Operador CCU, activará la unidad, señalando en medidas privadas la circunstancia (**Recabando información**) que recibirá la unidad en su 2º mensaje de texto.

Durante la misión, si el alertante aporta o corrige datos sobre la patología del alertante. El Operador CCU, trasladará la información a la unidad asignada, previo filtrado de Médico/Enfermero CCU, confirmando la recepción.

Consideraciones:

Durante la activación, el Operador CCU, facilitará los datos señalados anteriormente; omitiendo desde la unidad u operaciones, cualquier opinión personal sobre el asunto y pertinencia de la activación.

Del mismo modo, la asignación de una misión a una unidad conlleva la decisión del Médico/Enfermero CCU considerando la actividad sanitaria regional, por lo que la unidad omitirá cualquier pregunta sobre el estado de resto de unidades u opinión sobre las distancias, en caso de movilización fuera de zona habitual, ya ha sido ponderada por Médico/Enfermero CCU 061.

Durante el desempeño de la misión, la unidad mantendrá la operativa habitual, informando a CCU 061 de los diferentes estados de la unidad, a través de la telemática de la unidad TETRA o verbalmente por radiotelefonía TETRA o telefónicamente; requiriendo el recibido.

6. Documentos Base.

Se usan la documentación base generada por la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

- Movilización de Recursos.
- Evaluación de la Demanda.

Asistencia a Emergencias